흉통, 올바르게 이해하고 안심하기

가슴이 아프다고 모두 심장 문제는 아닙니다. 대부분은 근육·관절이나 소화기 원인이지만, 일부는 생명을 위협합니다.

걱정해야 할 흉통 vs 덜 걱정스러운 흉통

심장일 가능성이 있는 신호 — 진료를 서두릅니다	덜 걱정스러운 신호 — 그래도 확인은 진료로
• 가슴 가운데를 **짓누르는** 느낌 • 어깨·턱·팔로 퍼지는 통증 • 식은땀·구역질이 함께 • 움직이면 심해지고 쉬면 나아짐 • 5분 넘게 이어짐 · 숨참·실신·어지럼	• 손가락으로 정확히 짚을 수 있는 자리 • 자세를 바꾸거나 누르면 통증이 달라짐 • 속쓰림·신물 같은 위장 증상 • 쉬거나 소염제·제산제로 나아짐 • 몇 초 스치고 지나감 · 비틀거나 기침할 때만

흔한 원인(비율은 대략) — 근육·관절·갈비뼈 약 50% · 위식도 역류 약 10~20% · 폐·기관지 약 10~18% · 불안·공황 약 10~18%. **당뇨가 있는 분·65세 이상·여성**은 가슴이 덜 아파도 숨참·피로·체한 느낌으로 심장 문제가 올 수 있습니다.

이럴 때는 바로 119 — 약을 먹고 기다리지 마세요



1. **쥐어짜는 통증이 5분 넘게** — 혀 밑 니트로글리세린·휴식으로도 안 나아짐
2. **어깨·팔·턱·목으로 퍼짐** — 특히 왼팔 안쪽(새끼손가락 쪽)
3. **식은땀**이 함께 남
4. **가슴 통증과 함께 숨참**, 또는 **갑작스러운 심한 숨참** (통증 없이 숨참만 올 수도 있음)
5. **실신·어지럼·의식이 흐려짐**

갑자기 찢어지는 듯한 통증이 등·목으로 옮겨 감, 숨 쉴 때 찌르며 숨이 몹시 참, 심하게 토한 직후의 극심한 통증, 누우면 심해지고 앞으로 숙이면 나아지는 통증도 응급입니다(목 혈관이 부풀고 혈압이 떨어지면 매우 위험). **통증이 심하고 갑작스러우면 먼저 119** — 기다리는 동안에는 움직이지 말고 편한 자세로 쉬세요.

진료실에서는 이렇게 확인합니다

이 네 가지를 말씀해 주세요	검사와 그다음
• **어디가** — 아픈 자리, 퍼지는 방향 • **어떤 느낌** — 짓누르는·타는 듯한·찌르는 • **언제 심해지나** — 움직일 때·숨 쉴 때 • **함께 오는 증상** — 식은땀·숨참 등	• 몇 분 이어졌는지, 쉬면 나아졌는지 적어 오세요 • 새 숨참·설명 안 되는 피로 → **심전도 검사** • 필요하면 추가 검사나 전문의 의뢰 • 심장 검사가 정상이어도 다른 응급이 다 배제된 것은 아님

집에서 지킬 것 — 진료로 심장 등 다른 원인이 아니라고 들은 분

1~3일	4~7일	1~2주	다시 진료
냉찜질 15~20분씩 · 처방 소염제 · 충분한 휴식	온찜질로 바꾸기 · 가벼운 스트레칭·심호흡	조금씩 움직이기 · 한 시간에 한 번 깊은 숨	통증이 바뀔 때 · 2주 안에 안 나을 때

하지 마세요 — 갈비뼈를 복대·붕대로 꽉 감기 · 얕은 숨만 쉬기 · 무거운 물건 들기·상체 비틀기 · 처방 없이 진통제를 오래 먹기. 쉬는 동안 숨참·식은땀이 새로 생기거나 통증이 더 심해지면 바로 119.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

근거 — ACC/AHA 2021 흉통 지침 · 대한가정의학회(KAFM) 2024 · 대한응급의학회 · 광교바른내과 진료 안내

교육·참고용 안내문입니다. 원인 판단과 검사는 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/cardio/chest-pain/